

21. DAS LIGAMENTUM LILIEQUIST

DAUER : 07:37

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit der Anatomie und den Mechanismen des Ligamentum Liliequist, einer wesentlichen Struktur, die als Diaphragma auf der Höhe des dritten Ventrikels fungiert. Es wird erläutert, wie dieses Band mit dem Nervus oculomotorius und dem Basilaris interagiert und so das ventrikuläre System und die Hypophyse beeinflusst. Die Konzepte von Membranspannungen, Achsen der Schädelbewegung und deren Auswirkungen auf das Gesichts- und Hormonsystem werden behandelt, wobei die Bedeutung der kraniosternalen und mandibulären Bewegungen hervorgehoben wird. Die Analyse von Spannungen kann auch bei der Diagnose von okklusalen Dysfunktionen helfen und therapeutische Schlüssel zur Wiederherstellung der körperlichen Harmonie bieten.

DAS LILIEQUIST-LIGAMENT: ANATOMIE UND MECHANISMEN

Das **Liliequist-Ligament** ist eine anatomische Struktur, die wie ein kleines Diaphragma wirkt und gemeinhin als **Liliequist-Membran** bezeichnet wird. Dieses Ligament setzt am **dritten Ventrikel** an und reicht bis zum **Keilbein** hinab. Dort spielt es eine entscheidende Rolle in Bezug auf den **Nervus oculomotorius** und den arteriellen Durchgang, insbesondere den **Basilarisstamm**, der für die Bildung der **Hirnarterien** verantwortlich ist.

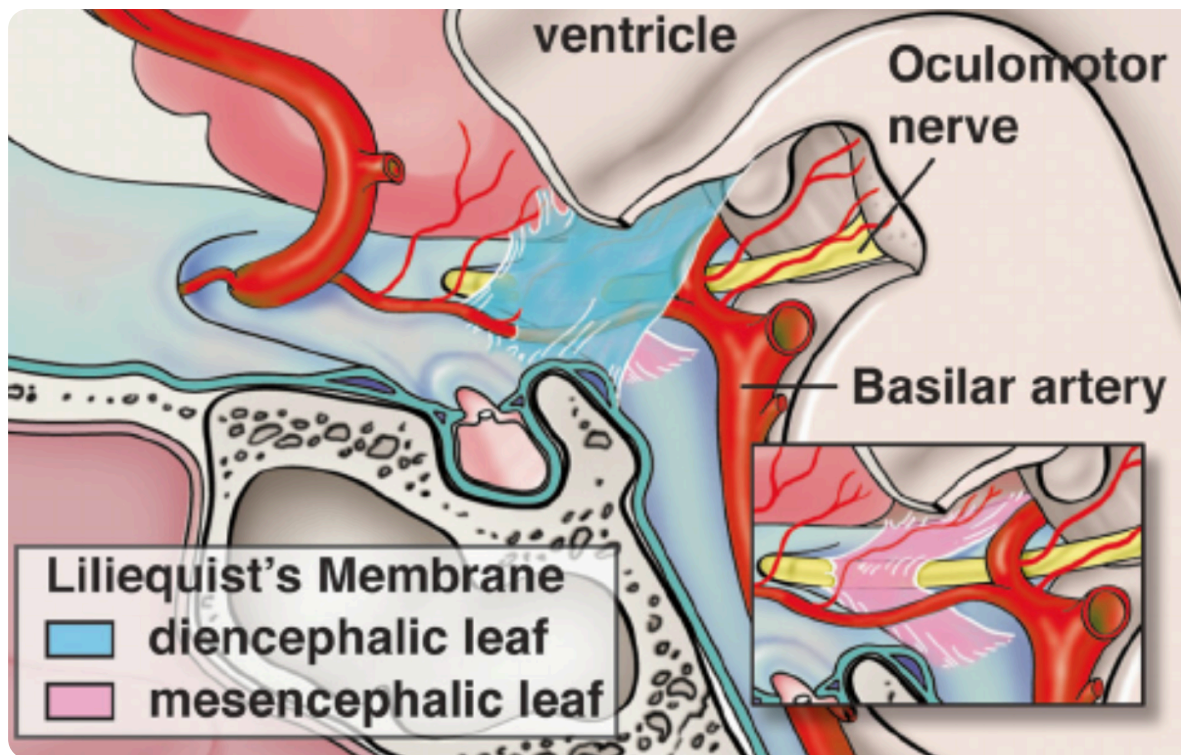


ABB. — Liliequist-Band

Wenn das Ligament herabsteigt, erzeugt es eine **Spannungsachse**, die das **ventrikuläre System** beeinflusst. Der dritte Ventrikel, der vierte Ventrikel sowie die **Seitenventrikel** sind alle durch diese Dynamik miteinander verbunden. Es entsteht ein Spannungsmuster, das einen signifikanten Einfluss auf den Raum hat, in dem sich die **Hypophyse** befindet.

Oberhalb der Hypophyse befindet sich das **Chiasma opticum**, das um etwa 30 Grad ausgerichtet ist, mit einer posturalen Bewegung von 5 Grad. Diese Bewegung ist essenziell für die **Drainage** zwischen dem dritten Ventrikel, dem Keilbein und den umgebenden **Mikrogefäßen**. Die in den Mikrokapillaren vorhandenen **Perizyten** interagieren mit den Nerven und bilden **Blut-Hirn-Schranken-Räume**, die als tiefer Stützpunkt dienen.

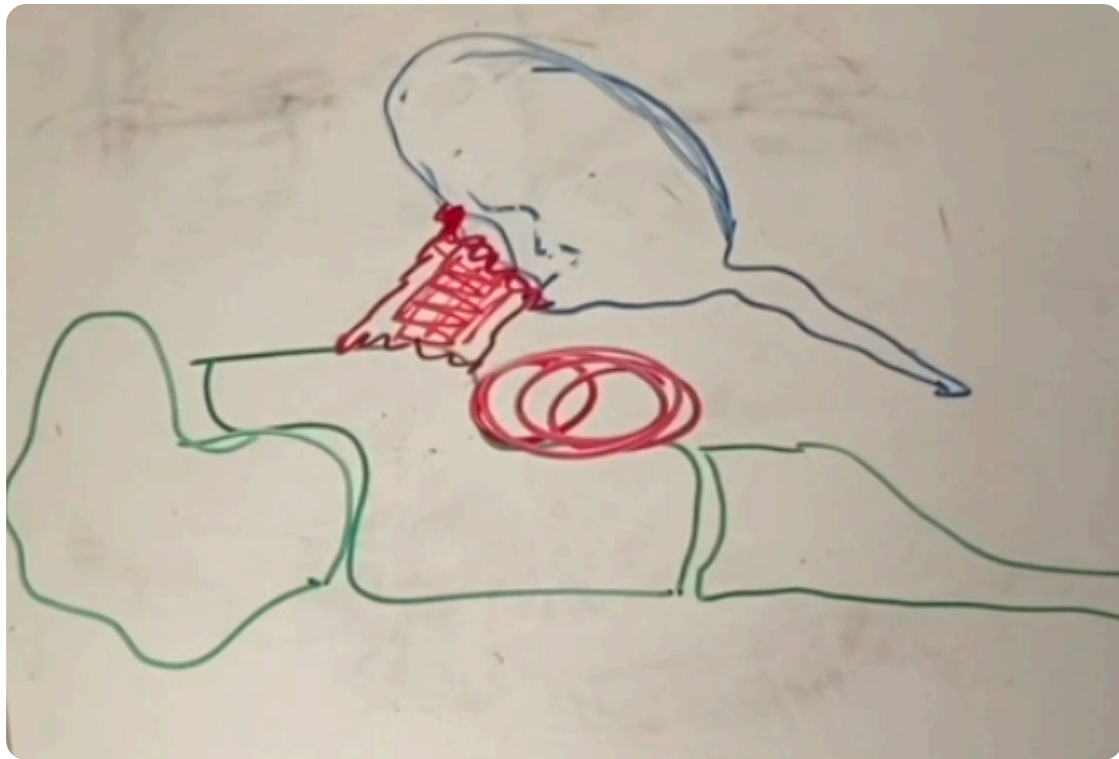


ABB. — Ventrikelsystem

Bei der Untersuchung der **Präspheoide**, die dem **Hinterhaupt** entsprechen, beobachtet man einen Gleichgewichtsraum auf der Lilliequist-Membran. Diese membranöse Spannung beeinflusst sowohl die Nerven als auch die Blutgefäße und befindet sich in der Nähe der Hypophyse, wo das Nervensystem über die **hypothalamisch-hypophysär-thyreoidal-adrenal-gonadale Achse** mit dem Hormonsystem kommuniziert.

Die kraniale Bewegung ist ebenfalls wichtig zu berücksichtigen. Bei der Betrachtung eines Schädels kann man die verschiedenen Bewegungen an den **Parietalen** und anderen Strukturen feststellen. Diese Bewegungen folgen spezifischen Kraftlinien. Zum Beispiel stellt die **Flexionsbewegung** im Stirnbereich, verbunden mit der **Sutura metopica**, zwei Gleichgewichtspunkte dar, die die Augenbewegung beeinflussen.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass das **Gehirn** das **ventrikuläre System** und das **Gesichtssystem** sowohl auf der Ebene des **Chondrocraniums** (Knorpel) als auch des **Desmocraniums** (Membran) konditioniert. Während der Entwicklung, wenn das **Hinterhaupt** herabsteigt, steigt auch das **Kreuzbein** herab, und die **Schläfenbeine** spielen eine Schlüsselrolle in dieser Dynamik.

Das **Brustbein** steigt als Reaktion auf diese Bewegungen auf und konvergiert zur vorderen Mittellinie. All dies ist im Auge eingeschrieben, und es ist unerlässlich, Elemente bezüglich des Gesichtssystems und des Kapselsystems des Auges hinzuzufügen, die sich um das Ganze herum einfügen und es mit einer Gegenrotation bei der Entwicklung der Orbita organisieren.

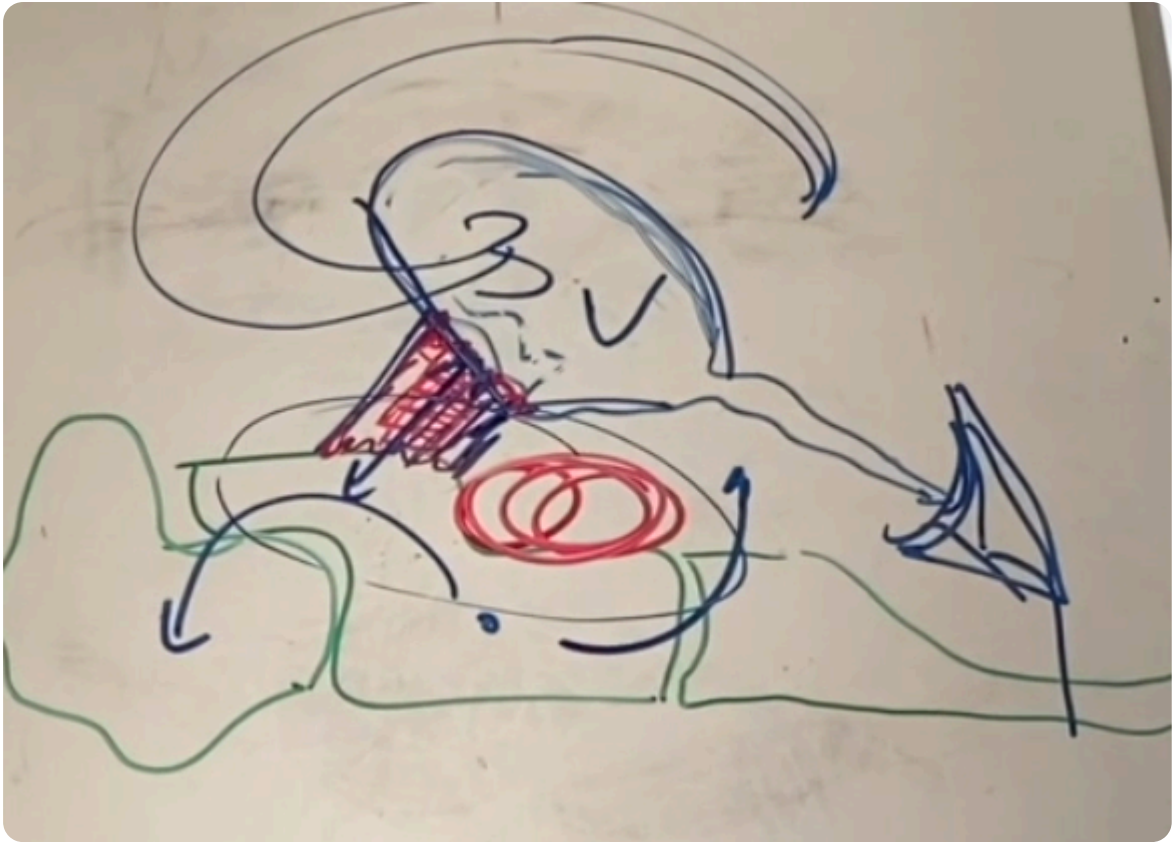


ABB. — Kopf-Bewegungen

Die kranio-sterno-sakralen und mandibulären Bewegungen sind miteinander verbunden. Die Eckzahnachsen sind ebenfalls wichtig, da sie die **Okklusion** beeinflussen. Wenn die obere und untere Eckzahnbegegnung nicht korrekt ist, führt dies zu einem Informationsverlust im Gehirn, da diese elektrischen Felder sich vereinigen müssen.

Die **Okklusion** ist somit ein Spiegelbild der Spannungen, die auf der **Symphysis sphenobasilaris** vorhanden sind. Durch die Beobachtung der Zähne ist es möglich, das Vorhandensein von **Strain** (Spannung) zu bestimmen, sei es vertikal, lateral oder anders. Dies ermöglicht es, die Belastungen zu verstehen und die notwendigen Behandlungen anzupassen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.

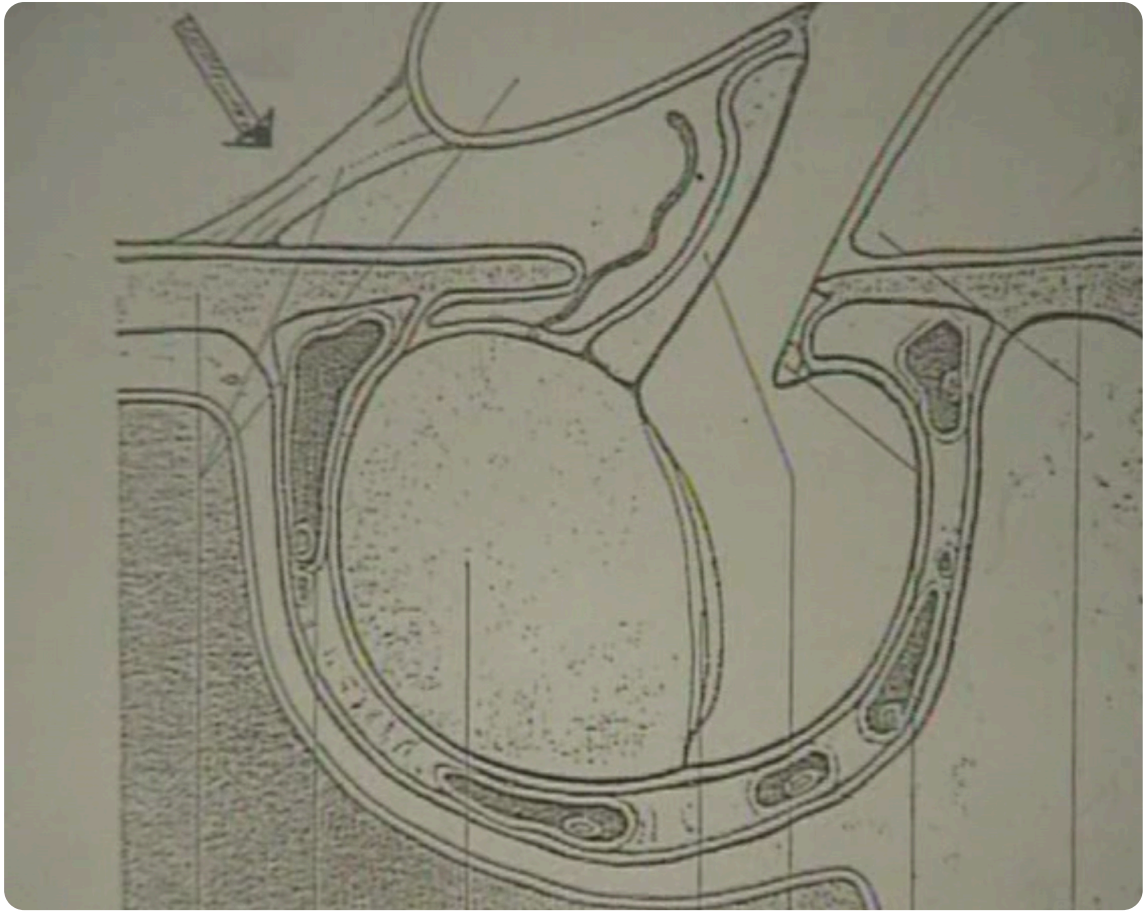


ABB. — *Koordinierte Bewegungen von Schädel, Sternum und Sakrum*